



LOGO

Osteoartrite do Joelho

Segurança e Eficácia da Curcumina vs Diclofenaco no Tratamento da Doença



Distribuição:
NOVAERA
HOMEOPATIA • MANIPULAÇÃO

Osteoartrite do Joelho

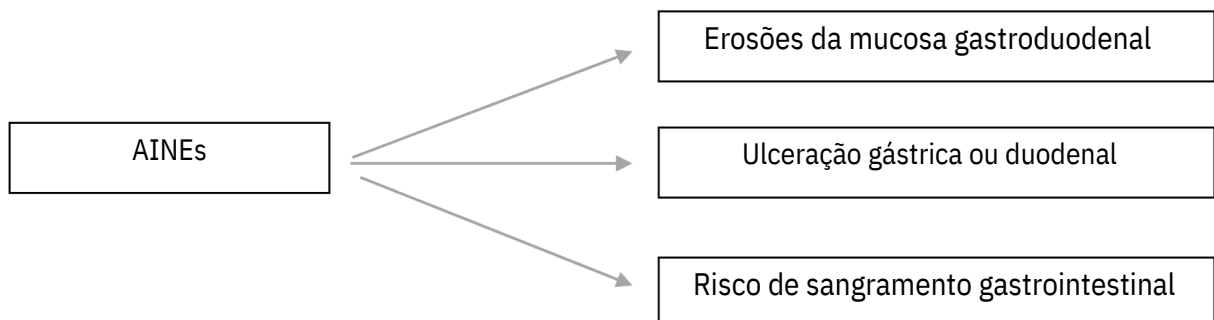
Características e Tratamento

A osteoartrite do joelho (OA) é a quarta principal causa de incapacidade. Os sintomas da OA do joelho normalmente começam após os 40 anos de idade, contudo podem afetar pessoas mais jovens após uma lesão traumática. Além disso, é altamente prevalente entre pacientes obesos, e a incidência estimada é de 10% a 15% na população acima de 60 anos de idade.

A dor é um dos principais sintomas que levam os indivíduos a procurar atendimento médico e contribui para limitações funcionais e redução da qualidade de vida.

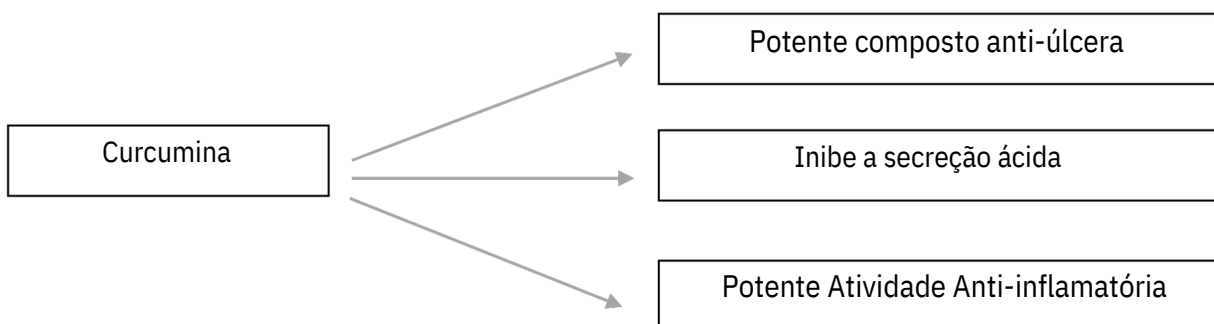
Terapia Farmacológica Usual

A terapia farmacológica usual de primeira linha para a OA do joelho consiste em anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), que são altamente efetivos no controle dos sintomas para a maioria dos pacientes, no entanto seu uso prolongado pode estar associado a diversos problemas de saúde.



Curcumina

A curcumina é um composto polifenólico derivado do açafrão que possui diversas propriedades farmacológicas e biológicas, e tem atividade semelhante ao ibuprofeno no tratamento da OA nos joelhos.



Estudo Comprova

Curcumina é Benéfica no Tratamento da OA nos Joelhos

Um estudo clínico randomizado, aberto, paralelo e controlado teve como objetivo avaliar a eficácia e segurança da curcumina comparada ao diclofenaco no tratamento da osteoartrite (OA) do joelho (Shep *et al.*, 2019).

Para isso, 139 pacientes com OA no joelho foram randomizados em dois grupos, no qual receberam durante 28 dias:



- Os pacientes foram submetidos a avaliação no início e nos dias 7, 14 e 28.

Resultados:

Nos dias 14 e 28, os pacientes que receberam curcumina apresentaram melhora semelhante na gravidade da dor e na escala *Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score* (KOOS) quando comparados com o diclofenaco, e a diferença não foi estatisticamente significativa;

- No dia 7, os pacientes que receberam curcumina experimentaram uma redução significativamente maior no número de episódios de flatulência em comparação com o diclofenaco ($P < 0,01$);
- No dia 28, um efeito de redução de peso ($P < 0,01$) e efeito anti-úlceras ($P < 0,01$) de curcumina foram observados.
- Os efeitos adversos foram significativamente menores no grupo da curcumina (13% *versus* 38% no grupo do diclofenaco ($P < 0,01$)).

Conclusão:

A curcumina tem eficácia semelhante ao diclofenaco, mas demonstrou melhor tolerância entre os pacientes com OA do joelho podendo ser uma opção de tratamento nos pacientes são intolerantes aos efeitos colaterais dos medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais.

Formulário 1

Formulações para o Tratamento da Osteoartrite do Joelho

Curcumina	
Curcumina.....	500 mg
Excipiente qsp.....	1 Cápsula
Administrar 1 cápsula 3 vezes ao dia ou conforme orientação médica.	

Associação Anti-inflamatória na Osteoartrite de Joelho

Associação Anti-Inflamatória	
N-acetil-D-glucosamina.....	500 mg
Extrato de Gengibre.....	250 mg
<i>Boswellia serrata</i>	180 mg
Excipiente qsp.....	1 Cápsula
Administrar 3 cápsulas ao dia durante a primeira semana, depois administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme orientação médica/nutricional.	

De acordo com os resultados do estudo de Bolognesi *et al.* (2016), após 1, 3 e 6 meses de suplementação com N-acetil-D-glucosamina, gengibre e *Boswellia serrata* em pacientes com osteoartrite de joelho moderada, os pacientes apresentaram melhora significativa dos parâmetros funcionais e distância percorrida livre de dor. Além disso, todos os sinais e sintomas da doença avaliados pelo WOMAC tenderam a regredir após a suplementação.

Formulário 2

Formulações para o Tratamento da Osteoartrite

Extrato de Alho em Pacientes com Osteoartrite

Cápsulas de Alho

Extrato de alho..... 500 mg

Excipiente qsp..... 1 Cápsula

Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme orientação do médico.

Estudo conduzido por Dehghani *et al.* (2018) investigou os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios da suplementação de extrato de alho em pacientes com osteoartrite. Após 12 semanas, a concentração de resistina foi diminuída no grupo 1, que recebeu o tratamento (6,41 para 5,56 ng/ml – $p=0,008$); Os níveis de TNF- α não sofreram alterações significativas nos dois grupos; Os escores que medem a dor foram reduzidos de maneira significativa no grupo 1 (6,8 para 5,3 – $p=0,002$), mas não no grupo placebo (6,7 para 6,2 – $p=0,002$).

Referências Bibliográficas

Bolognesi G1, Belcaro G, Feragalli B, Cornelli U, Cotellese R, Hu S, Dugall M. Movardol® (N-acetylglucosamine, Boswellia serrata, ginger) supplementation in the management of knee osteoarthritis: preliminary results from a 6-month registry study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Dec;20(24):5198-5204.

Dehghani S1, Alipoor E2, Salimzadeh A3, Yaseri M4, Hosseini M4, Feinle-Bisset C5, Hosseinzadeh-Attar MJ6. The effect of a garlic supplement on the pro-inflammatory adipocytokines, resistin and tumor necrosis factor-alpha, and on pain severity, in overweight or obese women with knee osteoarthritis. Phytomedicine. 2018 Sep 15;48:70-75. doi: 10.1016/j.phymed.2018.04.060. Epub 2018 May 9.

Jorge Martínez-Íñiguez Blasco, Andrés Aguirre*, Erena Gil- Quintana and Marisa Fenaux. The effect of daily administration of 300 mg of ovomet® for treatment of arthritis in elderly patients. Research Article - International Journal of Clinical Rheumatology (2016) Volume 11, Issue 5.

Shep D, Khanwelkar C, Gade P, Karad S. Safety and efficacy of curcumin versus diclofenac in knee osteoarthritis: a randomized open-label parallel-arm study. *Trials*. 2019;20(1):214. Published 2019 Apr 11. doi:10.1186/s13063-019-3327-2